

VEILLE INFORMATIONNELLE

L'Intelligence Artificielle dans le Domaine Médical

Avancées, enjeux et réglementation

Période couverte	1er octobre 2025 – avril 2026
Formation	BTS SIO – 1ère année
Rendu le	Avril 2026

1. Introduction

Dans un monde où le numérique redessine en profondeur les contours de la médecine, l'intelligence artificielle s'impose peu à peu comme l'un des moteurs les plus puissants de transformation du secteur de la santé. Diagnostiquer plus vite, personnaliser les traitements, détecter des pathologies invisibles à l'œil nu, optimiser la gestion hospitalière... les promesses sont immenses et, fait notable, elles commencent aujourd'hui à se concrétiser dans des environnements cliniques réels.

C'est ce bouillonnement technologique qui m'a conduit à choisir ce thème pour ma veille informationnelle. En tant qu'étudiant en BTS SIO, dont la formation est profondément ancrée dans les systèmes d'information et les infrastructures numériques, observer l'essor de l'IA dans le domaine médical représente bien plus qu'une curiosité intellectuelle : c'est une fenêtre directe sur ce que seront les systèmes de demain, leurs architectures, leurs contraintes de sécurité, leurs exigences en matière de données. La santé numérique est l'un des secteurs qui génère le plus de besoins en compétences informatiques, et la veille sur ce terrain m'a semblé particulièrement pertinente pour envisager mes futurs débouchés professionnels.

La période couverte, du 1er octobre 2025 à avril 2026, s'est révélée exceptionnellement riche. En moins de sept mois, on est passé d'une IA médicale encore en phase d'expérimentation à une technologie qui **entre de plain-pied dans les cabinets, les services d'urgence et les hôpitaux**. Les jalons réglementaires se sont accumulés, les dispositifs approuvés par les autorités sanitaires ont explosé, et les débats éthiques se sont considérablement affinés. C'est cette dynamique que cette veille s'attache à restituer.

2. Présentation du sujet et justification du choix

Le sujet de cette veille peut se formuler ainsi : **comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle le domaine médical, et quels sont les verrous techniques, éthiques et réglementaires qui conditionnent son déploiement ?** L'IA médicale recouvre un spectre très large d'applications, que l'on peut regrouper en quatre grands axes :

- **L'imagerie médicale augmentée** : des algorithmes analysent radiographies, IRM et scanners avec une précision qui rivalise avec les spécialistes humains.
- **La médecine prédictive** : à partir des données patient, l'IA anticipe des risques (insuffisance cardiaque, diabète, sepsis) et déclenche des alertes préventives.
- **L'aide à la décision clinique** : des systèmes experts assistent médecins et pharmaciens lors du diagnostic ou de la prescription.
- **La recherche pharmaceutique accélérée** : l'IA réduit drastiquement les délais de découverte de nouveaux médicaments, de 6 ans à parfois 30 mois.

Ce choix se justifie par l'actualité réglementaire brûlante : 2025-2026 est une période charnière, avec l'AI Act européen, l'Espace Européen des Données de Santé (EHDS), la stratégie nationale française 2025-2028, et les investissements massifs de la Commission européenne. Autant d'événements qui font de cette période un moment **décisif à observer** pour qui s'intéresse à l'avenir des systèmes d'information en santé.

3. Outils utilisés

Une veille efficace ne s'improvise pas : elle repose sur un dispositif structuré combinant des outils automatiques, une exploration manuelle régulière et la surveillance des réseaux sociaux professionnels. Voici comment j'ai organisé mon écosystème de veille, semaine après semaine, pendant plus de six mois.

3.1 Vue d'ensemble

Outil	Type	Fréquence	Pertinence
Google Alerts	 Automatique	Quotidien	★★★★★
Feedly	 Automatique	3x/semaine	★★★★★
Arxiv.org	 Manuel	Hebdomadaire	★★★★★
OMS / Santé.gouv	 Manuel	Hebdomadaire	★★★★★
LinkedIn	 Réseau social	Quotidien	★★★★★

3.2 Détail des outils

■ Google Alerts – Outil automatique principal

Google Alerts constitue la colonne vertébrale automatique de ma veille. J'ai configuré des alertes sur : « **IA santé** », « **intelligence artificielle médecine** », « **AI healthcare** », « **AI Act médical** ». Chaque matin, une synthèse atterrit dans ma boîte mail. Cet outil est redoutablement efficace pour ne rien rater de l'actualité immédiate, mais il tend à surreprésenter les sources grand public. Je l'utilise donc comme **filet de sécurité**, pas comme source unique.

■ Feedly – Agrégateur de flux RSS

Feedly me permet de centraliser les flux RSS de sources spécialisées : **Health Data Hub**, **Agence du Numérique en Santé**, **STAT News**, **campusmedx.fr**, **buzz-esante.fr**. Je le consulte le mercredi soir pour faire le tri entre informations de surface et articles de fond.

■ Arxiv.org, Santé.gouv.fr & Commission européenne – Consultation manuelle

Arxiv me permet de suivre les prépublications académiques. J'ai ajouté en 2026 la page IA de la **Commission européenne** (digital-strategy.ec.europa.eu), devenue une mine d'or avec les rapports publiés en mars et avril 2026. Cette consultation manuelle est plus chronophage, mais de loin la plus riche analytiquement.

■ LinkedIn – Réseau social professionnel

J'ai suivi des comptes comme le **Health Data Hub**, l'**Agence du Numérique en Santé**, **Galeon** ou encore plusieurs chercheurs en IA médicale. L'avantage est la dimension **réactive et communautaire** : les débats sous les posts capturent des opinions expertes introuvables ailleurs. L'inconvénient est le risque promotionnel, que je contre en croisant toujours avec des sources primaires.

💡 **Mon rituel de veille (7 mois)** Lundi matin : lecture des alertes Google. Mercredi soir : tour de Feedly et LinkedIn. Vendredi : consultation manuelle d'Arxiv et de [santé.gouv.fr](https://sante.gouv.fr) / Commission européenne + prise de notes sur les événements de la semaine. Ce rythme a tenu sur toute la période, avec une montée en puissance progressive des sources institutionnelles européennes à partir de janvier 2026.

4. Synthèse chronologique des informations collectées

Cette synthèse retrace les évolutions les plus significatives de la période couverte, semaine par semaine jusqu'en décembre 2025, puis mois par mois à partir de janvier 2026. Trois fils conducteurs traversent l'ensemble : la **maturité croissante des outils** sur le terrain clinique, l'**accélération du cadre réglementaire** (AI Act, EHDS, stratégies nationales), et la **montée en puissance des questions éthiques** et de responsabilité.

PARTIE I — OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025



1er – 6 octobre 2025 : Premiers signaux réglementaires

Dès le début d'octobre, la veille fait apparaître une préoccupation centrale : comment encadrer les IA médicales de façon rigoureuse et uniforme ? Dans le prolongement de la consultation publique menée jusqu'au 22 septembre 2025, de nombreux articles analysent les résultats et posent la question de la gouvernance des données. Des hôpitaux pilotes commencent à expérimenter des solutions d'aide au diagnostic dans un cadre encadré par la DGOS.

- **Événement clé** : La Commission européenne annonce le 21 octobre 2025 le lancement de **COMPASS-AI** — une communauté multidisciplinaire pour une mise en oeuvre sûre de l'IA en pratique clinique.
- **Source** : ANFH — [Lancement de COMPASS-AI](#)

7 – 20 octobre 2025 : Les approbations FDA s'enchaînent

La FDA publie une mise à jour indiquant que **873 dispositifs médicaux intégrant de l'IA** ont désormais reçu une approbation aux États-Unis — soit environ 115 nouveaux en 2025. La société **Aidoc** annonce des mises à jour de son système de **multi-triage** capable d'identifier simultanément embolies pulmonaires, hémorragies intracrâniennes et fractures sur scanner CT. Ce type de système permet de prioriser les cas urgents et de réduire les délais de prise en charge aux urgences de plusieurs heures.

- **Chiffre clé** : 873 DM IA approuvés par la FDA au 31 juillet 2025, dont ~115 nouveaux dans l'année.
- **Source** : IntuitionLabs — [AI in Radiology: 2025 Trends, FDA Approvals & Adoption](#)

21 – 31 octobre 2025 : Biais, responsabilité, boîtes noires

Une série d'articles scientifiques et de débats experts pointent les **limites éthiques et techniques des IA médicales**. Trois problèmes reviennent en boucle : les biais algorithmiques (modèles moins précis sur certains groupes ethniques), la « boîte noire » (algorithmes incapables de justifier leurs décisions), et la responsabilité juridique (qui est responsable en cas d'erreur — médecin, fabricant ou établissement ?). La HAS publie en avril 2025 de nouvelles directives, mais des zones grises demeurent. La résistance culturelle des médecins reste un obstacle majeur à l'adoption.

- **Source** : acmcorpo.fr — [IA en Médecine : 8 Applications Révolutionnaires en Santé 2025](#)
- **Source** : campusmedx.fr — [IA en radiologie : innovations, applications cliniques et enjeux en 2025](#)

28 oct. – 10 novembre 2025 : L'AI Act classe les IA médicales à « haut risque »

Les IA médicales sont officiellement classifiées comme **systèmes « à haut risque »** au sens du Règlement européen sur l'IA (AI Act). Cette classification impose : documentation technique exhaustive, transparence envers les utilisateurs, surveillance post-commercialisation, conformité avec les normes harmonisées. Plusieurs hôpitaux en France amorcent des **projets pilotes encadrés** avec un budget de 2 millions d'euros alloués par la DGOS.

- **Dispositif notable** : AISight Dx (PathAI) — outil d'anatomo-pathologie IA approuvé, accélérant la revue des lames histologiques.
- **Source** : Usine Digitale — [L'accès aux données, axe central de la feuille de route gouvernementale](#)

11 – 17 novembre 2025 : EchoNext surpasse les cardiologues

L'IA **EchoNext**, spécialisée dans la détection des cardiopathies structurales, démontre dans une évaluation contrôlée qu'elle diagnostique **mieux que des cardiologues expérimentés**, avec des performances constantes quel que soit le groupe ethnique ou le contexte clinique. L'outil identifie même des cardiopathies chez des patients sans antécédent d'imagerie préalable. De même, **Eko Low EF AI** reçoit une validation pour détecter en quelques secondes une faible fraction d'éjection — marqueur précoce d'insuffisance cardiaque — lors d'un examen standard.

- **Source** : Wikipedia — [Intelligence artificielle dans la santé](#)



12 novembre 2025 : La France publie sa stratégie nationale IA et données de santé

C'est l'événement phare de l'automne 2025. Lors de la 4e Journée nationale de l'innovation en santé numérique, le ministère de la Santé présente le volet IA de la **stratégie nationale « IA et données de santé 2025-2028 »**. Quatre priorités : clarifier le cadre réglementaire, évaluer rigoureusement les solutions IA, accompagner les professionnels, et bâtir un modèle économique durable. La France participe aussi au projet européen **SHAIPED** (cadre d'évaluation pour DM-IA, 30 partenaires) et au programme **PARTAGES** (modèles de langage en santé, 20 CHU).

- **Source** : Health Data Hub — [Publication de la stratégie nationale sur l'IA et les données de santé](#)
- **Source** : Ministère de la Santé — [IA et données de santé : une stratégie nationale](#)



Décembre 2025 : Convergence réglementaire et bilan de fin d'année

Les dernières semaines de 2025 sont consacrées à une observation analytique plus globale. On perçoit une **convergence progressive entre les cadres réglementaires** : AI Act, EHDS et stratégie française 2025-2028 forment un ensemble cohérent. Le débat se cristallise sur la frontière entre IA **clinique** (certifiée, évaluable) et IA de **bien-être** (apps grand public, chatbots santé), qui échappe pour l'heure à la plupart des contraintes réglementaires — un angle mort préoccupant pour la sécurité des patients.

- **Source** : GPM.fr — [IA et données de santé : une révolution sous conditions](#)
- **Source** : buzz-esante.fr — [Numérique en santé : les 10 tendances majeures à suivre en 2026](#)



Bilan T4 2025 En trois mois, l'IA médicale est passée d'un sujet expérimental à une réalité institutionnelle. La France a son plan national, l'Europe son règlement, et la FDA ses 873 dispositifs approuvés. Les freins ne sont plus technologiques mais organisationnels, culturels et réglementaires.

PARTIE II — JANVIER À AVRIL 2026



Janvier 2026 : L'IA sort des hôpitaux, entre dans les cabinets

Janvier 2026 marque un basculement symbolique fort : le 6 janvier, l'État américain de l'Utah autorise la start-up **Doctronic** à utiliser l'IA pour renouveler des prescriptions de routine dans certaines maladies chroniques. C'est une première mondiale. L'histoire d'un robot qui gère une ordonnance semblait relever de la science-fiction ; elle est désormais réalité réglementaire.

En France, l'**Assurance maladie** et la **HAS** lancent une expérimentation pour évaluer l'impact médico-économique de l'IA dans l'interprétation des ECG — un projet qui vise à donner aux médecins des outils supplémentaires tout en améliorant le parcours de soin. Parallèlement, les agents IA (capables d'exécuter des tâches complètes, de la priorisation des symptômes à la planification d'exams) commencent à être déployés dans des services hospitaliers sous tension.

- **Tendance émergente** : En 2026, 88 % des professionnels de santé prévoient d'intensifier l'usage de l'IA dans les deux prochaines années, selon les enquêtes de la période.
- **Source** : CGM.com — [Intelligence artificielle et médecine : quel usage en 2026 ?](#)
- **Source** : Futura Sciences — [L'IA n'est plus un simple outil médical, quelque chose est en train de changer](#)
- **Source** : medtechfrance.fr — [Les nouvelles technologies médicales à suivre en 2026](#)



Février 2026 : L'IA testée face aux vrais patients — et les limites apparaissent

Février apporte une publication scientifique majeure et très commentée. Le 9 février, **Nature Medicine** publie une étude britannico-américaine comparant trois applications d'IA médicale en conditions réelles avec de vrais patients — et non dans des tests théoriques. Résultat édifiant : les IA qui s'en sortaient très bien dans les évaluations standards **underperforment significativement** lorsqu'elles interagissent avec de vrais patients. La raison ? Les patients ne savent pas quelles informations fournir, et les applications n'ont pas été conçues pour gérer cette imperfection naturelle. La conclusion est sans appel : aucune des trois n'est « prête pour un déploiement dans les soins directs aux patients ».

Parallèlement, la revue **Médecine & Droit** publie un article de Diane de Saint-Affrique sur les enjeux juridiques de l'IA responsable en santé, qui fait le tour des enjeux de transparence, biais, consentement éclairé et responsabilité médicale. Du côté de la recherche pharmaceutique, la société **Insilico Medicine** a démontré qu'elle peut passer de la simulation informatique aux essais cliniques en seulement **30 mois** (contre 6 ans habituellement), grâce à l'IA — une percée majeure pour la découverte de médicaments contre la fibrose pulmonaire.

- **Chiffre clé** : Les tâches administratives mobilisent entre 25 et 35 % du temps des médecins (DREES) — l'IA générative commence à absorber cette charge.
- **Source** : Agence Science-Press — [IA et conseils médicaux : il y a du chemin à faire](#)

- **Source** : Sermo.com — [Comment l'IA remodèle le développement des médicaments en 2026](#)
- **Source** : espace-ethique-azureen.fr — [IA et médecine : quand les avancées technologiques redéfinissent les règles d'une IA responsable](#)
- **Source** : galeon.care — [IA et médecine en 2026 : ce que les médecins peuvent déléguer à l'intelligence artificielle](#)



Mars 2026 : 1 450 dispositifs FDA, étude européenne et l'AI Act en suspens

Mars 2026 apporte deux informations structurantes. Premièrement, le total de dispositifs médicaux intégrant de l'IA approuvés par la FDA atteint **environ 1 450**, selon les données compilées par l'UNIGE. En l'espace de huit mois seulement (depuis juillet 2025 où l'on en comptait 873), ce chiffre a pratiquement doublé. Pour le Pr Douglas Teodoro, spécialiste de l'IA médicale à l'Université de Genève, c'est la preuve que « **des promesses, on est passé à la réalité** ».

Deuxièmement, la Commission européenne publie le 17 mars une **étude approfondie sur l'IA dans les systèmes de santé** européens, qui dissèque les technologies de santé numérique déployées dans les 27 États membres. L'étude révèle une adoption très inégale et souligne les efforts d'harmonisation à mener. Sur le plan réglementaire, une proposition législative dite « **Digital Omnibus** » évoque un report de 12 mois pour l'entrée en application de l'annexe I de l'AI Act (repoussée au 2 août 2028), ce qui donne davantage de temps aux fabricants de DM-IA pour se mettre en conformité.

- **Approche émergente** : L'apprentissage fédéré (les algorithmes se déplacent vers les données, et non l'inverse) devient la norme pour garantir la souveraineté des établissements et la confidentialité des patients.
- **Source** : UNIGE — [L'IA médicale à l'épreuve du réel](#)
- **Source** : Commission européenne — [Study on Artificial Intelligence in healthcare \(17 mars 2026\)](#)
- **Source** : G_NIUS / ANS — [AI Act : Ce que la nouvelle loi européenne change pour l'e-santé](#)



Avril 2026 : L'Europe investit massivement — 63 millions d'euros pour l'IA santé

Avril 2026 est sans doute le mois le plus riche en événements institutionnels depuis le début de cette veille. Le **7 avril**, la Commission européenne publie un rapport dédié à **l'IA dans les soins cardiovasculaires** (« De la promesse à la pratique »), qui recense les applications concrètes dans la prévention, le diagnostic et la réadaptation des maladies cardiovasculaires — première cause de mortalité en Europe.

Le **20 avril**, l'OMS/Europe publie le **tout premier état des lieux mondial de l'IA dans les soins de santé au sein des États membres de l'UE**. Les chiffres sont frappants : **74 % des pays de l'UE** déclarent recourir à l'IA pour le diagnostic, et **63 %** utilisent des chatbots pour impliquer les

patients dans leur traitement. Mais l'étude souligne un retard alarmant dans la formation du personnel soignant à l'IA.

Enfin, le **21 avril**, la Commission européenne annonce la mise à disposition de **63,2 millions d'euros** pour soutenir l'innovation en matière d'IA dans la santé et la sécurité en ligne. Cet investissement cible notamment les **centres de dépistage avancé** basés sur l'IA pour la détection précoce du cancer et des maladies cardiovasculaires, s'appuyant sur la plateforme **Cancer Image Europe** (objectif : 60 millions d'images médicales d'ici fin 2026) et sur l'initiative **1+Million Génomes**.

- **Chiffre clé** : 74 % des États membres de l'UE utilisent déjà l'IA pour le diagnostic (OMS/Europe, avril 2026).
- **Chiffre clé** : 63,2 M€ investis par la Commission européenne pour l'IA en santé (21 avril 2026).
- **Source** : OMS/Europe — [Premier état des lieux de l'IA dans les soins de santé dans l'UE \(20 avril 2026\)](#)
- **Source** : Commission européenne — [63,2 M€ pour l'IA en santé et sécurité en ligne \(21 avril 2026\)](#)
- **Source** : Commission européenne — [IA dans les soins cardiovasculaires : de la promesse à la pratique \(7 avril 2026\)](#)

💡 **Bilan avril 2026** En six mois, on est passé de 873 à ~1 450 DM-IA approuvés par la FDA. 74 % des pays de l'UE utilisent l'IA en diagnostic. La Commission injecte 63,2 M€. L'OMS publie son premier état des lieux mondial. Le basculement vers une médecine augmentée par l'IA n'est plus un horizon : c'est le présent.

5. Conclusion

Cette veille de six mois sur l'intelligence artificielle dans le domaine médical — d'octobre 2025 à avril 2026 — a été une expérience aussi instructive sur la forme que sur le fond. Elle aura surtout confirmé une chose : l'IA médicale n'est plus un domaine de recherche futuriste. Elle s'ancre dans le quotidien des urgences, des cabinets de radiologie, des pharmacies hospitalières et même, désormais, des renouvellements d'ordonnance en Utah.

Trois grandes leçons se dégagent de cette période. Premièrement, le **rythme de l'innovation est non-linéaire et s'accélère** : en moins d'un an, le nombre de dispositifs médicaux IA approuvés par la FDA est passé de 873 à 1 450. Deuxièmement, le **déploiement réel reste plus difficile que la technologie** : l'étude de Nature Medicine de février 2026 l'a démontré sans détour — une IA performante en tests théoriques peut échouer face à de vrais patients. Troisièmement, le **cadre réglementaire se structure enfin mais avec des retards** : l'AI Act européen, solide sur le papier, voit ses délais d'application se décaler (annexe I reportée à 2028), ce qui laisse des angles morts préoccupants.

L'investissement de 63,2 millions d'euros annoncé par la Commission européenne le 21 avril 2026, combiné aux données de l'OMS (74 % des pays de l'UE utilisent l'IA pour le diagnostic), dessine une trajectoire claire : l'Europe choisit de ne pas laisser ce secteur aux seuls États-Unis et à la Chine. La souveraineté numérique en santé est devenue un enjeu géopolitique.

Sur la forme, cette veille m'a permis d'adopter un véritable **rituel de travail informationnel** : sélectionner des sources fiables, distinguer l'information de fond du bruit médiatique, croiser les perspectives techniques, institutionnelles et éthiques. Des compétences directement utiles dans mon parcours en BTS SIO, où la capacité à se tenir informé des évolutions technologiques est une exigence permanente.

Une certitude s'impose en guise de mot final : le médecin qui sait utiliser l'IA n'est pas menacé. En revanche, le médecin qui ne sait pas l'utiliser risque de prendre du retard. Et derrière chaque algorithme performant, il y a des ingénieurs, des architectes de systèmes d'information, des experts en cybersécurité des données de santé — autant de métiers que nous, étudiants en BTS SIO, apprenons à exercer.

Fin du compte-rendu de veille informationnelle – BTS SIO | Octobre 2025 – Avril 2026